

GUIA PARA EMPRESAS DE TODOS OS SETORES

Outubro Rosa
além do laço

Como facilitar o cuidado, apoiar as pessoas e acompanhar os impactos para o negócio

Lideranças · RH · Saúde ocupacional
Informação, acesso e acolhimento
Edição atualizada · outubro de 2026

ESCUTARIS

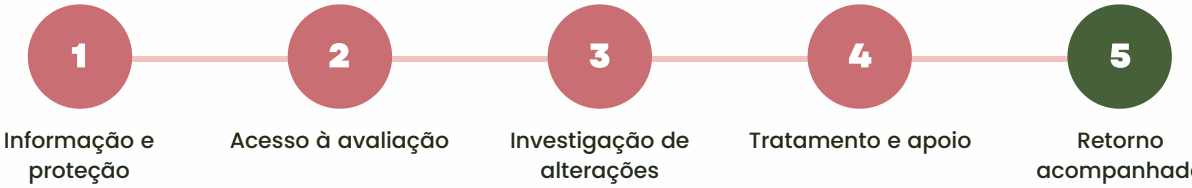
Como usar este guia

Orientações de gestão propostas pela Escutaris. Referências clínicas e legais na página 21.

Este material ajuda lideranças, RH e equipes de saúde a organizar o cuidado com o câncer de mama em empresas de qualquer setor ou porte. A proposta é transformar a mobilização de outubro em condições de acesso durante todo o ano.

A empresa pode informar, facilitar consultas e exames indicados, acompanhar barreiras e apoiar o tratamento e o retorno ao trabalho. O atendimento clínico cabe aos profissionais de saúde. As escolhas da pessoa e a confidencialidade precisam orientar todas as etapas.

Um percurso de cuidado



Uma pessoa com sintomas entra diretamente na avaliação diagnóstica, sem esperar uma campanha.

Onde encontrar cada tema

01 Entender o tema
Contexto, fatores de risco e proteção · **p. 3**

02 Perceber e rastrear
Sinais, rastreamento e homens · **p. 6**

03 Direitos e acesso
A lei e o fluxo de acesso · **p. 9**

04 Tratamento e acolhimento
Saúde mental, liderança, colegas e retorno · **p. 11**

05 Custos e plano de ação
Sinistralidade, orçamento e indicadores · **p. 16**

06 Caso e referências
Caso para discussão e fontes · **p. 20**

PRIMEIRO PASSO

Escolha uma pessoa responsável por articular RH, saúde ocupacional, lideranças e rede de atendimento. Em empresas pequenas, essa função pode contar com apoio do serviço de saúde contratado.

PARTE 01

Entender o tema

Por que o câncer de mama faz parte da gestão, o que aumenta o risco e o que a empresa pode facilitar para proteger a saúde.

Por que o tema faz parte da gestão

Fonte: INCA, Câncer de mama [1]. Interpretação e propostas de gestão da Escutaris.

78.610

NOVOS CASOS POR ANO

O INCA estima 78.610 novos casos de câncer de mama feminina por ano no Brasil no triênio 2026–2028. O número dimensiona o problema nacional. Ele não permite prever quantos casos ocorrerão em uma empresa.

O adoecimento repercute na vida da pessoa e de sua família. No trabalho, pode exigir ausências, redistribuição de atividades e adaptações. A organização precisa planejar esses apoios e considerar as despesas assistenciais, sem reduzir a pessoa ao custo do tratamento.

Três conceitos que ajudam a agir

1

Prevenção primária

Reduzir fatores de risco e oferecer condições favoráveis à saúde.

2

Rastreamento

Exames em pessoas sem sintomas, conforme indicação.

3

Diagnóstico precoce

Avaliar rapidamente alterações suspeitas.

Essas ações se complementam. Uma campanha com grande participação perde alcance se quem recebe um resultado alterado não consegue concluir a investigação.

PARA A DIRETORIA

Definir responsáveis, recursos e acompanhamento do acesso. A mesma atenção deve alcançar diferentes cargos, turnos e unidades.

PERGUNTA PARA COMEÇAR

Se alguém perceber uma alteração hoje, saberá onde buscar avaliação e como ajustar sua rotina de trabalho?

Fatores que aumentam o risco

Fontes: INCA, Câncer de mama e Fatores de risco [1, 4].

O câncer de mama tem múltiplas causas. Conhecer fatores de risco ajuda a orientar a avaliação, mas não determina quem terá a doença.

História pessoal e familiar

Idade, histórico familiar, alterações genéticas e aspectos da história hormonal e reprodutiva influenciam o risco. Casos de câncer de mama em homens da família ou diagnósticos em idade jovem merecem ser relatados ao profissional de saúde.

Fatores sobre os quais é possível agir

Consumo de álcool, inatividade física e excesso de gordura corporal, especialmente após a menopausa, estão entre os fatores relevantes. Certas exposições no trabalho também exigem avaliação e controle conforme as atividades exercidas.

O uso de hormônios deve ser discutido com o profissional responsável. A campanha não deve orientar suspensão ou início de medicamentos por conta própria.

NA EMPRESA

Facilitar orientação de saúde e revisar riscos aplicáveis ao trabalho. Dados familiares e genéticos pertencem à esfera clínica e não devem orientar seleção, promoção ou exclusão de pessoas.

INFORMAR SEM CULPAR

A ausência de histórico familiar não elimina o risco. Ter hábitos saudáveis também não oferece garantia absoluta. A comunicação deve abrir caminhos para o cuidado, sem julgamento.

Proteção com condições reais

Fontes: INCA, Câncer de mama e Fatores de risco [1, 4].

Atividade física, manutenção de peso adequado e evitar bebidas alcoólicas contribuem para reduzir o risco. A amamentação também é um fator de proteção, quando possível. Essas medidas não substituem avaliação clínica ou exames indicados.

O que a empresa pode facilitar

- Criar oportunidades para movimento e pausas compatíveis com a atividade.
- Oferecer informação acessível e encaminhamento para orientação nutricional e de saúde.

- Apoiar quem deseja e pode amamentar, respeitando suas condições.
- Identificar e controlar exposições ocupacionais pertinentes à realidade da empresa.

Apoiar escolhas requer considerar jornada, transporte, renda e responsabilidades familiares. Uma mensagem sobre hábitos saudáveis tem mais utilidade quando vem acompanhada de condições para colocá-los em prática.

EXEMPLO

Incluir equipes de todos os turnos nas ações e divulgar serviços de saúde acessíveis. Não condicionar reconhecimento ou benefícios à perda de peso, à amamentação ou à divulgação de informações pessoais.

O objetivo é ampliar possibilidades de cuidado. Pessoas com bons hábitos também podem adoecer e precisam do mesmo acolhimento.



PARTE 02

Perceber e rastrear

Que alterações pedem investigação, quem tem indicação de rastreamento e como a informação chega a toda a equipe, homens incluídos.

Alterações que pedem investigação

Fonte: INCA, Câncer de mama, sinais e sintomas [1].

Uma mudança suspeita na mama precisa de avaliação profissional, mesmo antes da idade de rastreamento ou após uma mamografia anterior normal.

1. Nódulo novo ou persistente na mama ou na axila, sobretudo endurecido, fixo ou em crescimento.
2. Retração da pele ou aparência de casca de laranja.
3. Mudança recente no formato do mamilo.
4. Secreção espontânea, principalmente de um lado ou com sangue.
5. Aumento progressivo ou lesão persistente na mama.

Essas alterações podem ter causas benignas. Avaliar permite definir se são necessários exames de imagem ou biópsia. Uma suspeita não equivale a um diagnóstico.

Como orientar

Conhecer o próprio corpo ajuda a perceber mudanças, sem exigir uma técnica rígida de autoexame mensal. Ao notar uma alteração suspeita, a pessoa deve procurar o serviço de saúde sem esperar o próximo Outubro Rosa.

PARA A LIDERANÇA

Facilite a avaliação. Evite minimizar a alteração, interpretar exames ou pedir que a pessoa aguarde a campanha da empresa.

Rastreamento com indicação

Fontes: INCA, Detecção precoce e acesso à mamografia no SUS [2, 3].

50 a 74

ANOS, A CADA DOIS ANOS

A referência deste guia é o INCA/Ministério da Saúde: mamografia de rotina dos 50 aos 74 anos, a cada dois anos, em pessoas sem sinais ou sintomas. Outras entidades médicas podem adotar protocolos diferentes.

No SUS, pessoas de 40 a 49 anos e acima de 74 podem ter acesso sob demanda, após orientação profissional sobre benefícios e riscos. Quem tem alto risco precisa de acompanhamento individualizado.

A orientação do INCA também contempla homens trans e pessoas não binárias designadas no feminino ao nascer que mantêm as mamas. O atendimento deve considerar anatomia, histórico e risco individual.

BENEFÍCIOS E LIMITES

O rastreamento pode reduzir a mortalidade na população indicada. Pode também produzir falso-positivos, falso-negativos, sobrediagnóstico e intervenções desnecessárias. A decisão deve ser informada e respeitada.

Para o programa

A equipe de saúde define elegibilidade e necessidade de exame no ciclo. RH facilita o acesso, sem prescrever mamografia para todas as pessoas.

Com sintomas

O caminho é a investigação diagnóstica, em qualquer idade. Não se deve esperar a próxima rodada de rastreamento.

Homens também precisam de informação

Fonte: INCA, Câncer de mama e orientações de detecção precoce [1, 2].

1%

DOS CASOS

O câncer de mama também ocorre em homens, embora seja raro e represente cerca de 1% dos casos. A baixa frequência pode favorecer demora na procura por atendimento.

Nódulo na mama, retração ou secreção pelo mamilo merecem avaliação. Não há indicação de mamografia de rotina para todos os homens. A conduta depende da avaliação clínica e do risco individual.

Uma campanha que alcance toda a equipe

- Usar linguagem que deixe claro que alterações nas mamas também importam para homens.
- Informar um caminho de atendimento sem constrangimento.
- Incluir diferentes turnos, funções e unidades na comunicação.

Câncer de mama masculino na família pode ser relevante para a avaliação de predisposição hereditária. Essa conversa pertence ao atendimento de saúde e deve permanecer sob sigilo.

> EXEMPLO DE MENSAGEM
>
> Percebeu uma alteração na mama ou no mamilo? Procure avaliação. Nosso canal de saúde pode orientar o acesso ao atendimento.

A inclusão dos homens na comunicação não deve se limitar a tratá-los como acompanhantes. Eles também podem precisar de avaliação e apoio.



PARTE 03

Direitos e acesso

O que a lei garante, o que a empresa precisa informar e como tirar do caminho os obstáculos de agenda, transporte e custo.

Direito aos exames e dever de informar

Fontes: Leis nº 13.767/2018 e nº 15.377/2026 [5, 6].

3 dias

A CADA 12 MESES

Para empregados regidos pela CLT, o art. 473, XII, prevê ausência por até três dias em cada 12 meses de trabalho para exames preventivos de câncer devidamente comprovados, sem prejuízo do salário. O direito foi incluído pela Lei nº 13.767/2018.

A Lei nº 15.377, de 2 de abril de 2026, acrescentou deveres de informação. As empresas devem disponibilizar informações oficiais sobre vacinação, HPV e os cânceres de mama, colo do útero e próstata, promover conscientização e orientar o acesso aos serviços de diagnóstico.

A lei também exige informar sobre a possibilidade de ausência prevista na CLT. Ela reforça a comunicação de um direito que já existia. Não se trata de três dias para cada tipo de câncer nem de benefício restrito a outubro.

Aplicação pelo RH

- Comunicar o direito e o procedimento de comprovação.
- Orientar gestores e organizar cobertura de escalas.
- Solicitar somente os dados necessários ao procedimento, preservando a privacidade.

ATENÇÃO AO REGIME

As regras acima se referem à CLT. Outros vínculos exigem consulta à norma aplicável. Subsídios e benefícios adicionais dependem de política própria.

Como facilitar o acesso

Proposta de organização do acesso. Referências clínicas e legais [2, 3, 5, 6].

Oferecer informação é parte do trabalho. O programa também precisa resolver obstáculos de agenda, transporte, rede credenciada e custo, conforme a realidade da organização.

Um fluxo simples

01 Divulgar um canal de orientação, inclusive para quem não tem plano de saúde.

02 Explicar como acessar a UBS ou a rede do plano e obter avaliação clínica.

03 Organizar horários e comprovação da ausência com o RH.

04 Oferecer apoio para agendamento e encaminhamento quando houver dificuldade.

05 Garantir que resultados alterados recebam orientação para investigação.

A equipe de saúde acompanha o cuidado com a autorização e a base legal pertinentes. A liderança não precisa receber laudos ou detalhes clínicos para organizar os ajustes de trabalho.

> **COMUNICAÇÃO SUGERIDA**
>
> O canal de saúde orienta consultas e exames indicados. O RH explica a ausência e a comprovação. Se houver barreiras de agenda ou acesso, fale com o responsável pelo programa.

A empresa deve tornar conhecidos os canais reais disponíveis, sem anunciar serviços que ainda não foram organizados. Convites e lembretes devem respeitar a decisão individual.



PARTE 04

Tratamento e acolhimento

O que muda no trabalho durante o tratamento, como cuidar da saúde mental e da confidencialidade, e o papel de lideranças e colegas até o retorno.

Tratamentos mais comuns

Fonte: INCA, Tratamento do câncer de mama [7].

O tratamento varia com a extensão da doença, as características do tumor e as condições e preferências da pessoa. Pode combinar modalidades em sequências diferentes.

MODALIDADE	EM TERMOS SIMPLES
Cirurgia	Retira parte ou toda a mama, conforme indicação.
Radioterapia	Trata uma região com radiação.
Quimioterapia	Usa medicamentos com ação no organismo.
Hormonioterapia	Atua em tumores sensíveis aos hormônios.
Terapias-alvo	Atuam em características específicas do tumor.

Nem toda pessoa recebe todos os tratamentos. Hormonioterapia oncológica não é reposição hormonal da menopausa. A equipe de oncologia define as opções e pode indicar outras terapias em situações selecionadas.

O que isso muda no trabalho

Consultas, fadiga e limitações funcionais podem exigir apoio. Os efeitos variam entre pessoas e fases do tratamento. A capacidade de trabalhar não deve ser presumida pela aparência ou pelo nome da terapia.

PARA A EMPRESA

Organize ajustes com a pessoa e a equipe de saúde. Não recomende tratamentos nem prometa um prazo de recuperação.

Saúde mental e confidencialidade

Fonte: Javan Biparva et al., PLOS ONE, 2023 [8]. Recomendações de acolhimento propostas pela Escutaris.

O diagnóstico pode trazer medo, mudanças na rotina e sofrimento emocional. Isso não acontece da mesma forma para todos. Acolhimento permite que cada pessoa expresse o que precisa sem cobrança por uma reação específica.

30,2%

PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO

Uma meta-análise global de 71 estudos estimou prevalência de depressão de 30,2% em mulheres com câncer de mama. Houve variação entre populações e métodos. O dado não permite diagnosticar uma pessoa nem projetar casos na empresa.

Apoio que respeita escolhas

- Oferecer encaminhamento para cuidado psicológico ou médico, conforme a necessidade.
- Perguntar se e como a pessoa deseja manter contato.
- Combinar o que pode ser compartilhado com a equipe.
- Preservar o acesso ao trabalho e às oportunidades, sem estigma.

QUEM VÊ O QUÊ

Prontuários e resultados ficam sob responsabilidade dos serviços de saúde. O gestor recebe as informações funcionais necessárias às adaptações. A diretoria acompanha dados agregados, com proteção de grupos pequenos.

PERGUNTA ÚTIL

Que apoio ajudaria neste momento e o que você prefere manter reservado?

O papel da liderança

Orientações práticas de gestão e acolhimento. Apoio à reintegração: Bilodeau et al. [9].

A liderança organiza condições de trabalho e abre um canal de conversa. O diagnóstico não exige que o gestor se torne um especialista em oncologia.

Na primeira conversa

Escute. Agradeça a confiança e pergunte qual apoio a pessoa deseja. Combine o que poderá ser comunicado, a quem e em qual momento. Não pressione para que ela conte detalhes do diagnóstico.

Na organização da rotina

- Acionar RH e saúde ocupacional para avaliar ajustes.
- Rever tarefas, metas e horários conforme as recomendações funcionais.
- Planejar a distribuição de atividades para evitar sobrecarga na equipe.
- Definir um contato de referência e uma data para rever os acordos.

Apoio não significa insistir para que a pessoa continue trabalhando durante o tratamento. Também não significa afastá-la das decisões e oportunidades sem necessidade ou avaliação.

FALA POSSÍVEL

Vamos entender quais ajustes são necessários e quem pode ajudar. Você pode nos dizer como prefere manter contato e o que podemos compartilhar.

Evite promessas sobre benefícios, estabilidade ou jornada antes de verificar as regras aplicáveis. Cumpra os acordos feitos e revise o plano quando a situação mudar.

Como os colegas podem apoiar

Recomendações práticas de convivência e acolhimento propostas pela Escutaris.

O apoio entre colegas pode aliviar dificuldades do cotidiano. A melhor forma de começar é perguntar, em vez de presumir.

Atitudes que ajudam

+ Oferecer ajuda concreta: uma tarefa combinada, uma orientação ou companhia, se desejada.
+ Manter o contato na frequência que a pessoa prefere.
+ Continuar a incluí-la nas conversas, respeitando sua disponibilidade.
+ Respeitar mudanças de humor e momentos em que ela não queira falar sobre saúde.

Atitudes que podem pesar

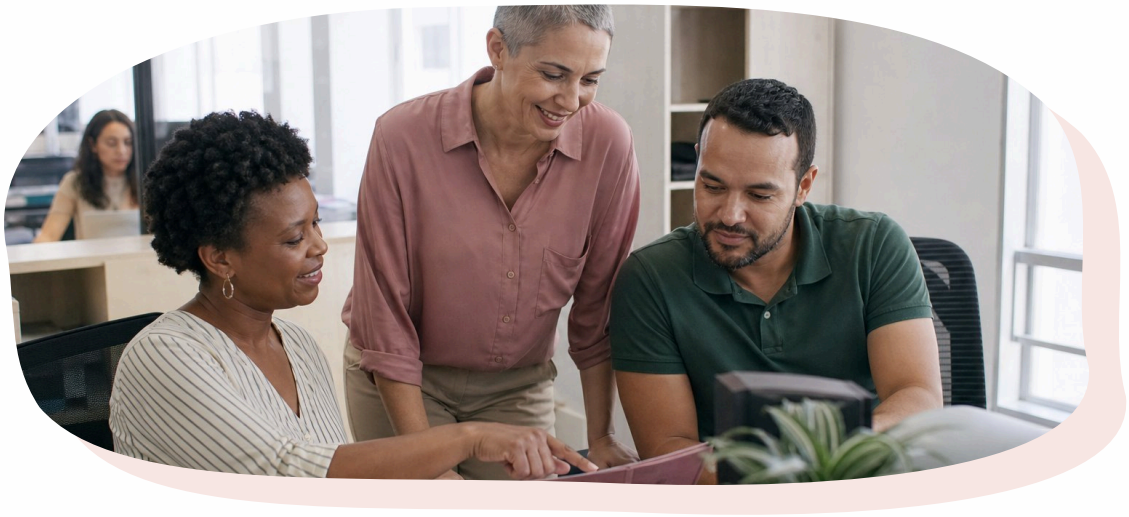
- Divulgar o diagnóstico sem permissão.
- Comentar a aparência.
- Comparar histórias de outras pessoas.
- Recomendar curas e tratamentos.
- Frases como “você precisa ser forte”, que podem trazer uma cobrança adicional.

“

TROQUE A COBRANÇA PELA OFERTA

Quer conversar ou prefere que eu ajude com algo específico?

A redistribuição de tarefas deve passar pela liderança. Ajuda informal permanente, sem planejamento, pode sobrecarregar colegas e fragilizar o apoio. A pessoa também pode preferir manter parte de sua rotina e falar de outros assuntos.



Retorno ao trabalho com acompanhamento

Fonte: Bilodeau, Tremblay e Durand, Current Oncology, 2019 [9].

O fim de uma etapa do tratamento não significa recuperação completa da capacidade funcional. Fadiga, dificuldades de concentração ou limitações físicas podem persistir. A avaliação precisa ser individual.

Um estudo qualitativo com nove sobreviventes no Canadá identificou lacunas de apoio na transição para o retorno. O resultado ajuda a reconhecer necessidades de continuidade, mas não

define uma regra universal de jornada ou acompanhamento.

Plano de retorno

01 Registrar atividades possíveis e restrições funcionais pertinentes.

02 Definir ajustes de tarefas, metas ou horários quando indicados e viáveis.

03 Identificar quem articula os apoios e quando o plano será revisto.

04 Manter espaço para comunicar dificuldades após a volta.

A pessoa, saúde ocupacional, RH e liderança devem articular o processo. Qualquer ajuste deve observar as regras trabalhistas e previdenciárias aplicáveis. Retorno gradual não é solução automática para todos.

REGISTRO MÍNIMO

Atividade e ajuste acordado; responsável; data de início; data de revisão; canal para pedir ajuda. Evite inserir o diagnóstico em documentos de circulação ampla.



PARTE 05

Custos e plano de ação

Como ler a sinistralidade sem prometer economia, estimar o orçamento do programa e acompanhar o acesso com indicadores claros.

Sinistralidade sem promessas de economia

Fontes: ANS, RN 518/2022 [10]. Scientific Reports, 2023 [11].

Sinistralidade	**despesas assistenciais ÷ receitas do plano × 100**, no mesmo período. Forma simplificada: o cálculo contratual deve ser confirmado com a operadora.

O cuidado oportuno pode favorecer tratamentos menos complexos. Isso não autoriza prometer redução fixa do custo ou do reajuste. Custos dependem de características do tumor, terapias, população, contrato e período observado.

36%

CUSTO MENSAL MAIOR

Um estudo brasileiro de saúde suplementar observou custo mensal por paciente 36% maior no câncer de mama triplo-negativo metastático, comparado ao grupo inicial e localmente avançado. Trata-se de um recorte específico, com dados de 2012–2017. Não representa todos os tumores nem comprova economia causada por uma campanha.

O que acompanhar

Acesso aos exames indicados, investigação de resultados alterados e orçamento do programa. Para analisar despesas do plano, considerar perfil etário, dependentes, tratamentos e inflação médica.

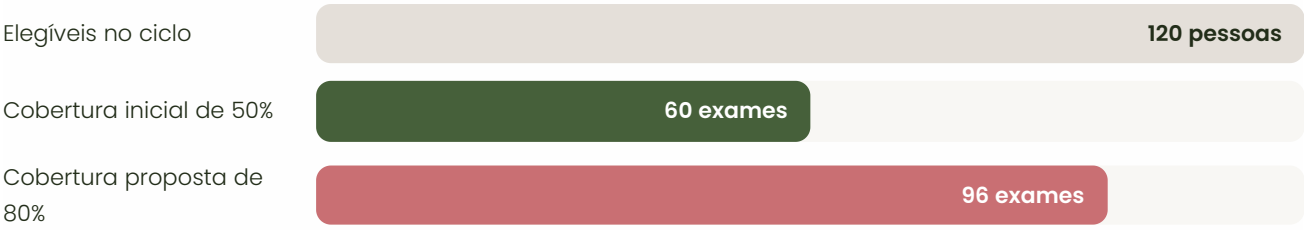
PARA A DIRETORIA

Melhorar o acesso pode aumentar a utilização no início. Compare períodos e contextos equivalentes. Não atribua automaticamente uma variação da sinistralidade à campanha.

Simulação de acesso e orçamento

Simulação didática da Escutaris. Todos os valores e percentuais desta página são hipóteses.

Considere uma empresa fictícia com 500 trabalhadoras. Para um ciclo definido, a equipe de saúde identifica 120 elegíveis ao exame. São premissas didáticas, sem previsão de diagnósticos.



A diferença entre as duas coberturas são 36 acessos adicionais.

MEDIDA	CENÁRIO ILUSTRATIVO
Elegíveis no ciclo	120 pessoas
Cobertura inicial de 50%	60 exames atualizados
Cobertura proposta de 80%	96 exames atualizados
Diferença	36 acessos adicionais
Subsídio de R$ 100 por 96 exames	**R$ 9.600**

O subsídio não é o preço total da mamografia. Se a empresa pagar apenas pelos 36 exames adicionais, o desembolso será de R$ 3.600. A política deve definir quem recebe o apoio e quais despesas ele cobre.

CUSTOS A INCLUIR NO PLANEJAMENTO

Coordenação, comunicação, horas de ausência e custos clínicos pertinentes, incluindo investigação de achados. Separe desembolso empresarial de despesas do plano para evitar dupla contagem.

CONCLUSÃO POSSÍVEL

Estimar o orçamento e medir acesso. Sem dados adicionais, não é possível afirmar quantos cânceres serão detectados ou qual será o retorno financeiro.

Plano de ação e indicadores

Modelo de implementação e indicadores propostos pela Escutaris.

Uma política pode começar com um plano de 90 dias e continuar ao longo do ano. Defina responsáveis e recursos compatíveis com o porte da empresa.

30 DIAS

Protocolo clínico, canais e comunicação dos direitos

ARTICULAÇÃO

RH e equipe de saúde

60 DIAS

Acesso e encaminhamento de alterações

ARTICULAÇÃO

Saúde e rede de atendimento

90 DIAS

Revisão do acesso e do orçamento

ARTICULAÇÃO

Gestão do programa e diretoria

Indicadores com denominador claro

Cobertura	**elegíveis com exame atualizado ÷ elegíveis no ciclo × 100**
Seguimento	**alterações com avaliação concluída ÷ alterações que exigem investigação × 100**
Tempo de investigação	**mediana dos dias** do resultado alterado até a conclusão diagnóstica

Defina fonte, período e responsável por cada indicador. Acompanhe também orçamento e dificuldades de acesso relatadas. Metas devem partir da situação local, sem premiar gestores pela exposição de dados de saúde.

PRIVACIDADE

O serviço de saúde consolida os dados. A diretoria recebe informações agregadas, com proteção de grupos pequenos.

PARTE 06

Caso para discutir na empresa

Caso fictício elaborado pela Escutaris para discussão de gestão.

EMPRESA FICTÍCIA HORIZONTE

A empresa fictícia Horizonte tem 500 trabalhadoras distribuídas entre áreas administrativas e operacionais. Há dificuldades de agendamento em diferentes horários. No ciclo do programa, 120 pessoas são elegíveis ao exame e 60 têm o cuidado atualizado. A proposta é alcançar 96.

Uma pessoa recebeu resultado alterado e ainda não conseguiu concluir a investigação. Outra se prepara para voltar após tratamento. A equipe quer ajudar, mas não sabe o que pode compartilhar ou como ajustar a rotina.

Decisões para o grupo

1
Quais barreiras precisam ser resolvidas e por quem?

2
Como priorizar o encaminhamento do resultado alterado?

3
Que apoios devem ser combinados para o retorno?

4
O que a diretoria pode acompanhar sem identificar pessoas?

PONTOS PARA CONFERIR

A meta representa 36 acessos adicionais. Subsidiar R$ 100 por todos os 96 exames custa R$ 9.600, sem os demais custos. A investigação do resultado alterado precisa de encaminhamento clínico. O retorno exige avaliação e acordos individuais. Esses dados não demonstram redução de sinistralidade.

AO FINAL

Registre três ações, um responsável por ação e uma data de revisão. O plano deve facilitar o cuidado sem obrigar a pessoa a divulgar seu diagnóstico.

Referências

Fontes consultadas em 16/10/2026. Os títulos são links clicáveis.

1. INCA. Câncer de mama: versão para população.
2. INCA. Detecção precoce: recomendação de rastreamento.
3. INCA. Informações para acesso à mamografia no SUS.
4. INCA. Fatores de risco do câncer de mama.
5. Brasil. Lei nº 13.767/2018. CLT, art. 473, XII.
6. Brasil. Lei nº 15.377/2026. Informação aos empregados.
7. INCA. Tratamento do câncer de mama.
8. Javan Biparva et al. Global depression in breast cancer patients. PLOS ONE, 2023. DOI 10.1371/journal.pone.0287372.
9. Bilodeau, Tremblay e Durand. Gaps and delays in survivorship care in the return-to-work pathway. Current Oncology, 2019. DOI 10.3747/co.26.4787.
10. ANS. Resolução Normativa nº 518/2022. Indicadores econômico-financeiros.
11. Treatment patterns and healthcare resource utilization for triple negative breast cancer in the Brazilian private healthcare system. Scientific Reports, 2023. DOI 10.1038/s41598-023-43131-9.

Conteúdo educativo para gestão. A avaliação clínica, a investigação e as decisões terapêuticas são individuais. As ferramentas de gestão e os cenários hipotéticos são propostas da Escutaris. Imagens ilustrativas, geradas por inteligência artificial.



UM COMPROMISSO DURANTE TODO O ANO

Revise o fluxo de acesso. Escolha os primeiros ajustes. Acompanhe se as pessoas conseguem concluir o cuidado indicado.

Faça isso com RH, saúde ocupacional e rede de atendimento, com responsáveis definidos para cada ajuste.

escutaris.com.br

Ciência que escuta, soluções que transformam.

ESCUTARIS